

LES DOULEURS ABDOMINALES

Plan du cours

I/Introduction

II/Sémiologie de la douleur abdominale :

- 1) Le siège de la douleur
- 2) L'irradiation
- 3) Le type de douleur
- 4) L'intensité
- 5) L'évolution
- 6) Les facteurs influençant la douleur
- 7) Les signes associés

III/ Principales causes de douleurs abdominales

- A. Douleurs gastriques
- B. Douleurs biliaires
- C. Douleurs pancréatiques
- D. Douleurs intestinales
- E. Douleurs de la péritonite
- F. Douleurs abdominales d'origine extra digestive

IV/ Différencier une douleur organique d'une douleur fonctionnelle

V Conclusion

Objectifs du cours

- Connaître les caractéristiques sémiologiques des douleurs abdominales
- Savoir évoquer (surtout si douleur aiguë) une urgence chirurgicale : Appendicite, Péritonite, occlusion intestinale...
- Penser à une cause extra-digestive devant une douleur abdominale : cardiaque, pleurale, métabolique...

I/ Introduction:

La douleur abdominale est un motif fréquent de consultation, qui revêt parfois un caractère urgent.

Devant toute douleur abdominale, les objectifs du praticien sont de préciser grâce à l'interrogatoire et de l'examen clinique les caractéristiques de la douleur abdominale afin d'avoir une orientation étiologique. Puis de prescrire les explorations adéquates et de rattacher la douleur à l'organe atteint.

II/Sémiologie de la douleur abdominale : Préciser les caractéristiques de la douleur

1 / LE SIEGE : La douleur abdominale est par définition, ressentie au niveau de l'un ou de plusieurs des 9 quadrants de l'abdomen : épigastre, hypochondres (droit et gauche), les flancs, hypogastre, fosses iliaques, région péri-ombilicale.

Plusieurs viscères peuvent donner lieu à une douleur de même siège.

En cas de douleur diffuse, on demande au patient de préciser le point le plus douloureux.

2/ L'IRRADIATION : souvent caractéristique : Ascendante, descendante, postérieure.

3/ LE TYPE :

a /La brûlure : est une douleur caractéristique lorsqu'elle siège dans l'épigastre et elle évoque une origine gastrique ou œsophagienne (pyrosis)

b/La crampe : douleur épigastrique, fixe, durable et profonde, sensation de torsion. Elle évoque une maladie gastrique ou duodénale.

c/La colique : est une douleur variable dans le temps et l'espace, caractérisée par des paroxysmes (de quelques heures) suivis d'accalmies.

d/ La dyspepsie : ensemble des symptômes épigastriques ou de la partie supérieure de l'abdomen dont l'origine est attribuée à l'estomac ou au duodénum à type de : lourdeur épigastrique postprandiale, impression de digestion lente, satiété précoce, nausées ou vomissements, ballonnements, éructations, pyrosis apparaissant pendant ou après le repas.

e/ La pesanteur : Sensation de lourdeur ou de retard à l'évacuation gastrique ...

f/ La douleur déchirante : En coup de poignard exp pancréatite ou perforation d'ulcère

4/ L'INTENSITE : de la douleur est un caractère subjectif : évaluer par : échelle de la douleur EVA Ou indirectement : si le patient a déjà consulté un médecin ou prise d'antalgiques.

Pour des douleurs chroniques : Evaluer le retentissement sur les activités du patient (Arrêts de travail), ainsi que sur le sommeil, notion de prise médicamenteuse antispasmodique

5/L'EVOLUTION :

a/Mode de début : Il est brutal ou progressif

b/Evolution : Allure évolutive de la douleur elle-même, sa durée et son caractère : douleur continue, permanente ou paroxystique.

c/ Horaire de survenue : rythmées par les repas (postprandiale), toute la journée ou sans horaire fixe. Le caractère nocturne → argument origine organique

d/ Evolution au long cours : par périodes (quelques jours à quelques semaines).

6/FACTEURS influençant la douleur :

a/ Les facteurs calmant : Position antalgique : antéflexion (douleur pancréatique)

-Aliments : cas du syndrome ulcéreux.

- Médicaments : Antiacides (douleurs œsogastriques), Antispasmodiques (colique hépatique, douleur d'origine intestinale)

- Vomissements : soulagent et témoignent d'une stase gastrique

- Emission de selles et gaz : douleur d'origine intestinale

- Loisirs : témoignent de troubles fonctionnels.

b/ Les facteurs aggravants : stress : troubles fonctionnels digestifs.

-aliments : alcool, vinaigre, jus de fruits (reflux, gastrite), repas gras

-médicaments gastro-toxiques (aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens)

7/SIGNES ASSOCIES:

a/Digestifs : pyrosis, dysphagie, vomissements, diarrhée, constipation, hémorragie digestive.

b/Extra-digestifs : urinaire, gynécologique, articulaires, dermatologiques.

c/Généraux : asthénie, anorexie, amaigrissement (signe d'alarme), fièvre, sueurs....

III/ PRINCIPALES DOULEURS DIGESTIVES :

A/LES DOULEURS GASTRIQUES :

1/ La douleur ulcéreuse :

SIEGE : Epigastre

TYPE : Crampe ou torsion, faim douloureuse

IRRADIATION : absence

INTENSITE : variable, parfois très intense

DUREE : d'une demi-heure à plusieurs heures

HORAIRE : rythmée et calmée par les repas, postprandiale ± tardif (possiblement nocturne)

FACTEURS CALMANTS : aliments, antiacides ou pansements gastriques

PERIODICITE : dans l'année, nette dans le syndrome ulcéreux

EXAMEN CLINIQUE : douleur provoquée du creux épigastrique

CAUSE : La fibroscopie digestive haute permet de poser le diagnostic.

a/. La maladie ulcéreuse gastrique ou duodénale

b/. Le cancer gastrique.

2 /La douleur de la perforation d'ulcère : complication de la maladie ulcéreuse :

-TYPE : Douleur déchirante, inhibant la respiration

-SIEGE : Epigastrique au début puis diffuse

-L'EXAMEN ABDOMINAL : contracture abdominale

-L'ASP (abdomen sans préparation) : pneumopéritoine, croissant gazeux sous hépatique

3 /La douleur de la gastrite :

-SIEGE : épigastrique, pas d'irradiation

-TYPE : Brulures, associée à un pyrosis

-PERIODICITE : postprandiale précoce

-Facteurs déclenchant : les repas

-Facteurs de sédation : Les pansements gastriques

-DIAGNOSTIC : Fibroscopie digestive haute (FDH)

4/La douleur du cancer gastrique :

Elle est atypique, peut ressembler à la douleur ulcéreuse, s'accompagne d'une altération de l'état général, rechercher un ganglion de Troisier.

Intérêt de la FDH devant tout syndrome douloureux épigastrique persistant.

B/ DOULEUR BILIAIRE OU « COLIQUE HEPATIQUE » :

Elle résulte de l'enclavement aigu d'un calcul dans l'infundibulum vésiculaire ou dans le canal cystique, avec rétention de la bile en amont ce qui provoque la douleur

SIEGE : Épigastre ou hypochondre droit.

TYPE : Torsion ou crampe

IRRADIATION : Epaule droite, omoplate droite, région inter-scapulaire

INTENSITE : +++ DUREE : plusieurs heures

FACTEURS DECLENCHANTS : repas gras

FACTEURS CALMANTS : antispasmodiques

Signes d'accompagnement: Vomissements (fin de crise), agitation, difficulté à l'inspiration.

Examen clinique : signe de Murphy : Douleur provoquée par la palpation.

CAUSE :

1. Lithiase biliaire (vésiculaire ou de la voie biliaire principale) +++ Diagnostic : échographie abdominale

2. Complications de la lithiase vésiculaire :

→Cholécystite aiguë

· Si le calcul vésiculaire responsable de « colique hépatique » ne se désenclave pas, le contenu vésiculaire peut s'infecter avec inflammation de la paroi, aboutissant à une cholécystite aiguë

· Signes cliniques : douleur de colique hépatique, vomissements, fièvre (38°-38,5°C)

· Signe de Murphy : tout en palpant le rebord costal droit au niveau de la ligne medio-claviculaire,

le médecin demande au patient de prendre une inspiration profonde. Le signe de Murphy est présent si la douleur au site de la palpation bloque l'inspiration, parfois une défense sous-costale

- Signes biologiques : syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose, bilan hépatique est normal
- Echographie (images inconstantes): vésicule distendue, épaississement de la paroi, calculs dans la vésicule ; douleur dans la région vésiculaire au passage de la sonde.

→ **Angiocholite aigue**

- Si la lithiasse migre et obstrue la voie biliaire principale, le tableau devient celui d'une Angiocholite avec sa triade symptomatique caractéristique s'installant en 24 à 72 h selon la séquence suivante : douleur puis fièvre élevée puis ictère

Signes biologique : syndrome inflammatoire, élévation modérée des transaminases, cholestase

Echographie : dilatation des voies biliaires intra et extra hépatique et présence d'un calcul enclavé dans la voie biliaire principale, une cholécystite est souvent associée.

3. Remarque : Des hépatalgies peuvent s'observer au cours de l'insuffisance cardiaque droite mais s'accompagne des signes droits : reflux hépato-jugulaire, turgescence des jugulaires, œdèmes des membres inférieurs

C/ DOULEUR PANCREATIQUE : type de description PANCREATITE AIGUE :

SIEGE : Epigastre ou sus-ombilical, parfois hypochondre droit ou gauche

TYPE : Crampe

IRRADIATION : Dorsale, transfixiante

INTENSITE : +++

DEBUT : brutal en coup de poignard on dit que c'est « un coup de tonnerre dans un ciel serein »

DUREE : plusieurs heures, voire plusieurs jours consécutifs

FACTEURS DECLENCHANTS : Repas gras, alcool,

FACTEURS CALMANTS : antéflexion (position penchée en avant), aspirine

Pas d'HORAIRE ni périodicité.

SIGNES D'ACCOMPAGNEMENT : Malaise, sueurs, vomissements, constipation (iléus), Diarrhée (stéatorrhée), amaigrissement.

EXAMEN CLINIQUE : douleur provoquée épigastrique ou péri-ombilicale,

CAUSE :

1. Pancréatite aiguë (cause : micro lithiasse biliaire, éthylique, hypertriglycéridémie, auto-immune, ...)

DIAGNOSTIC : Scanner abdominal initial puis au cours de l'évolution ce qui permet de classer le stade de la pancréatite et de rechercher les complications. La biologie : élévation de la lipasémie.

2. Pancréatite chronique : surtout lorsque la pancréatite est d'origine éthylique.

D/ DOULEURS INTESTINALES :

1/Les douleurs coliques (côlon)

SIEGE : Epigastre ou en cadre, les fosses iliaques, ou hypogastre

TYPE : Colique (augmente par paroxysmes)

IRRADIATION : Le long du cadre colique

INTENSITE : variable

DUREE : quelques minutes à quelques heures

FACTEURS DECLENCHANTS : multiples

FACTEURS CALMANTS : émission de selles ou de gaz +++, antispasmodiques

HORAIRE : absence ou postprandial

SIGNES D'ACCOMPAGNEMENT : gargouillement abdominal, ballonnement, troubles du transit (Constipation ou diarrhée), émissions glaireuses ou sanglantes

EXAMEN CLINIQUE : douleur en cadre sur le trajet colique

CAUSE :

1. Cancer du côlon
2. Colites inflammatoires (MICI) ou infectieuses
3. Syndrome de l'intestin irritable (SII)

Le SII est un trouble du tube digestif qui provoque des douleurs abdominales à type de crampes ou de coliques ; le patient décrira la même douleur à chaque crise qui

s'accompagnera d'une constipation ou une diarrhée, de ballonnement, de flatulences
Le SII représente 50 % de douleur abdominale, elle peut-être intense, diffuse, en cadre ou localisée, souvent en rapport avec la prise de certains aliments qui fermentent (choux, fèves, pois chiche, haricots ...) ou riches en glucides mal assimilés par l'intestin.

Le microbiote intestinal joue un rôle dans le mécanisme de ce syndrome

C'est un trouble digestif fonctionnel ayant souvent un caractère psychomoteur (facteurs émotionnels peuvent déclencher les symptômes).

L'examen clinique est normal en dehors du météorisme ou une sensibilité abdominale.

Le diagnostic sera retenu après des examens complémentaires pour exclure d'autres problèmes car le SII ne s'accompagne d'aucune anomalie organique lors d'une endoscopie.

Une modification du régime alimentaire et des médicaments soulagent le patient.

2/La douleur du grêle : type de description : Le syndrome de **Kœnig**

SIEGE : para-ombilicale ou hypogastrique fixe

TYPE : crise douloureuse paroxystique à type de coliques se prolongeant 30 minutes à 2 H, se terminant brusquement par l'émission de gaz et/ ou de matières fécales avec sensation de gargouillement

Horaire : postprandiale

Signes accompagnateurs : ballonnement abdominal, nausées, vomissements à l'acmé de la douleur

Cause : sténose intestinale d'origine inflammatoire le plus souvent (ex Maladie de Crohn).

3/La douleur appendiculaire : cf cours Appendicite

Siège : fosse iliaque droite

Signe de MC BURNEY : douleur provoquée de la fosse iliaque droite.

E/ LA DOULEUR DE LA PERITONITE : cf cours

Secondaire à la perforation d'un organe creux : estomac, intestin, appendicite, vésicule B

Permanente ; localisée puis diffuse.

F/ Douleurs abdominales d'origine extra-digestive

LA DOULEUR VASCULAIRE :

Infarctus iléo mésentérique : survient sur un terrain athéromateux ou cardiaque

Douleur atroce angoissante, permanent diffuse, accompagnée de signes de choc : pouls filant, hypotension artérielle, refroidissement des extrémités.

LA DOULEUR PARIETALE :

Exp: Hématome: Se voit dans les syndromes hémorragiques, post- traumatiques, malades sous anticoagulants, Souvent visible et la douleur augmente à l'inspiration profonde.

LA DOULEUR RAPPORTEE :

La douleur de l'infarctus du myocarde postérieur → douleur épigastrique

La douleur génitale (dysménorrhées ou rupture d'un kyste ovarien) → douleur fosse iliaque.

LES AUTRES DOULEURS:

-D'origine métabolique : acidocétose diabétique

-Douleurs anales : fissures anales, thromboses hémorroïdaires

-La douleur psychogène : femme ou adolescent, contexte psychologique.

IV/ Différencier une douleur organique d'une douleur fonctionnelle :

Devant des douleurs abdominales souvent anciennes, on doit savoir évoquer une origine fonctionnelle des douleurs abdominales

1. Présence de signes d'alarme en faveur d'une pathologie organique : âge (> 50 ans)
Amaigrissement, caractère nocturne des douleurs, Modification récente de symptômes anciens
2. Influence du stress et des facteurs psychologiques oriente plutôt vers une douleur fonctionnelle

Douleur fonctionnelle	Douleur organique
Absence de lésions organiques lors des explorations	Présence de lésions lors des explorations
Douleur ancienne Fréquente diffuse à tout l'abdomen ou variable lors de chaque examen	douleur récente et localisée
Pas de signes d'accompagnement	Présence de signes associés : • fonctionnels : hémorragies, vomissement • généraux : fièvre, perte de poids.
Terrain : contexte de stress, anxiété, psychique	

Conclusion :

Les douleurs abdominales sont un motif fréquent de consultation qui peuvent avoir plusieurs origines, d'où l'intérêt d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique soigneux. Afin d'orienter le diagnostic étiologique et les examens complémentaires.

Devant toute douleur aigue penser d'abord à une urgence chirurgicale. Eviter de délivrer un traitement symptomatique qui va retarder le diagnostic voire aggraver l'état du patient.